

dr. Hesti Herlinawati

12 Oktober 2026

[16.45, 12/10/2026]
Assalamu'alaikum, saat ini dr Hesti praktik di Madani ya. Saya minta tolong untuk menganalisa tentang faktor apa yang membuat angka rujukan ke RS di Madani jauh lebih tinggi dg angka rujukan di KMSC? Terima kasih 🙏🙏

[16.45, 12/10/2026]
Iya pelajari dulu ya krn tdk urgent, hanya ingin evaluasi untuk perbaikan ke depannya🙏🙏

A. Jenis Rujukan

Angka rujukan tinggi memang butuh evaluasi, tetapi tidak semua rujukan sama. Setidaknya rujukan harus dibagi menjadi 2 (dua) jenis, rujukan baru dan rujukan berulang. Karena dasar masalah dan cara penyelesaiannya berbeda.

1. **Rujukan Baru**

Definisi :

Rujukan yang dibuat untuk pasien yang belum pernah dirujuk sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama, atau sudah pernah tetapi episode penyakitnya sudah selesai dan sekarang muncul episode baru.

Kriteria :

- Tidak ada riwayat rujukan sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama.
- Atau ada riwayat, tetapi sudah lewat masa episode.
- Diagnosis bisa sama, tapi ini episode baru.

Contoh :

Pasien pernah dirujuk karena demam berdarah 1 tahun lalu, sekarang dirujuk lagi karena demam berdarah. Itu rujukan baru karena episode baru.

Dasar Masalah :

- Keterbatasan fasilitas klinik: alat, lab, radiologi, atau obat yang dibutuhkan tidak tersedia.
- Keterbatasan kompetensi: butuh dokter spesialis atau subspesialis yang tidak ada di klinik.
- Tingkat keparahan pasien: kondisi akut, gawat, atau butuh observasi/rawat inap.
- Diagnosis yang belum pasti: butuh pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis.
- Case mix pasien: klinik menerima lebih banyak pasien dengan penyakit kompleks.
- Kebijakan rujukan berjenjang: aturan asuransi mewajibkan rujukan untuk kasus tertentu.

Cara Penyelesaian :

- Perkuat fasilitas klinik: tambah lab, radiologi, USG, EKG, obat yang sering dibutuhkan.
- Perbaiki SOP rujukan: buat kriteria rujukan yang jelas.
- Tingkatkan kemampuan diagnostik: pelatihan dokter umum untuk kasus tak perlu rujuk.
- Analisis case mix: kalau rujukan baru tinggi karena pasien memang lebih berat, itu wajar. Fokusnya bukan menurunkan angka, tapi memastikan rujukan tepat.
- Audit rujukan: review sampel rujukan baru untuk melihat apakah ada yang seharusnya bisa ditangani di klinik.



dr. Hesti Herlinawati

2. Rujukan Berulang

Definisi :

Rujukan yang dibuat untuk pasien yang sudah pernah dirujuk sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama, dan masih dalam rangkaian masalah kesehatan yang sama.

Kriteria :

- Ada riwayat rujukan sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama.
- Masih dalam episode yang sama.

Contoh :

- Kontrol rutin
- Perpanjangan surat rujukan
- Rujukan ulang karena habis masa berlaku
- Perburukan kondisi yang sama

Dasar Masalah :

- Masa berlaku surat rujukan habis: aturan BPJS membatasi masa berlaku rujukan, sehingga pasien harus minta perpanjangan.
- Penyakit kronis yang butuh kontrol rutin: hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, dll. Pasien Prolanis/PRB.
- Follow-up yang tidak berjalan: pasien tidak kontrol teratur, sehingga kondisinya memburuk dan harus dirujuk lagi.
- Obat tidak tersedia di klinik: pasien harus ke RS untuk mendapat obat tertentu.
- Komunikasi dengan RS kurang: tidak ada rujukan balik, sehingga pasien kembali ke klinik dan dirujuk lagi.
- Edukasi pasien kurang: pasien tidak paham cara kontrol, minum obat, atau kapan harus kembali.
- Permintaan pasien/keluarga: pasien ingin tetap kontrol ke spesialis/RS yang sama.
- Kondisi memburuk: penyakit yang sama mengalami perburukan, sehingga butuh penanganan lanjutan.
- SOP perpanjangan rujukan tidak jelas: perpanjangan dilakukan tanpa evaluasi klinis yang memadai.

Cara Penyelesaian :

- Perjelas SOP perpanjangan rujukan: tentukan kriteria kapan rujukan boleh diperpanjang, kapan harus dievaluasi ulang.
- Optimalkan Prolanis/PRB: pastikan pasien kronis kontrol teratur di klinik, bukan hanya minta perpanjangan rujukan.
- Sediakan obat kronis: pastikan obat untuk penyakit kronis tersedia di klinik, sehingga pasien tidak perlu ke RS hanya untuk obat.
- Perbaiki komunikasi dengan RS: minta rujukan balik, koordinasi dengan spesialis, buat jalur komunikasi yang jelas.
- Edukasi pasien: beri pemahaman tentang penyakit, obat, kontrol, dan kapan harus ke RS.
- Audit perpanjangan rujukan: review apakah perpanjangan dilakukan tanpa evaluasi klinis.
- Manajemen kasus kronis: buat program follow-up untuk pasien kronis, misalnya reminder kontrol, konsultasi jarak jauh, atau kunjungan rumah.
- Evaluasi ketersediaan obat dan alat: pastikan apa yang dibutuhkan pasien kronis tersedia di klinik.



dr. Hesti Herlinawati

B. Metodologi

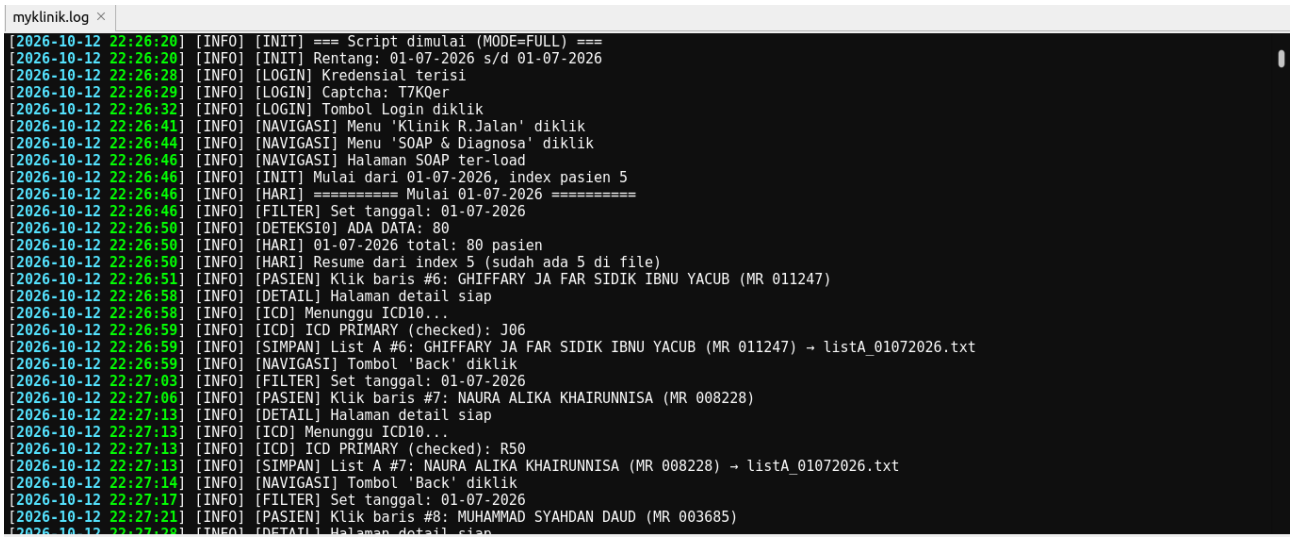
Untuk menjawab permintaan tentang faktor apa yang membuat angka rujukan ke RS di Madani jauh lebih tinggi dari angka rujukan di KMSC, maka perlunya perencanaan dan data yang akurat.

Perencanaan :

1. Data akan di ambil dari Rekam Medis Elektronik MyKlinik
2. Data yang diambil direntang yang sama yaitu 3 bulan, sesuai masa rujukan BPJS
3. Data diambil pada 1 Juli 2026 – 30 September 2026
4. Data yang diambil akan di bagi menjadi 2 list, List A dan List B
5. List A untuk hitung case mix dan denominator.
6. List B untuk klasifikasi jenis rujukan dan analisis alasan.
7. Hitung Case Mix dan Hitung Rate rujukan (umum dan perdiagnosis)
8. Bandingkan Madani vs KMSC
9. Kesimpulan dan Kemungkinan Faktor lain

C. Colecting Data Klinik Cahaya Madani

Dengan menggunakan python, kita lakukan otomatisasi colecting data dari myklinik





dr. Hesti Herlinawati

SEDANG PROSES COLECTING DATA PASIEN CAMAD